

Surveillances médicamenteuses à ne pas rater

Lithium • Clozapine • AOD/AVK | Fréquences explicites / exigences fortes

Lithium - TERALITHE

- Lithiémie : après équilibre : hebdomadaire 1er mois, mensuelle 1er trimestre, puis tous les 2 mois (RCP français).
- Régulièrement : créatininémie/fonction rénale, calcémie, TSH; ECG selon terrain.
- Rapprocher immédiatement en cas de déshydratation, AINS, IEC/ARA2, diurétiques, infection, modification sodée ou signes neuro-digestifs.

Clozapine - surveillance PNN obligatoire

- 1 fois/semaine pendant 18 semaines.
- Puis 1 fois/mois pendant 34 semaines (jusqu'à 12 mois).
- Après 12 mois sans neutropénie : toutes les 12 semaines.
- Après 24 mois sans neutropénie sur les 2 années précédentes : 1 fois/an.
- PNN immédiatement si fièvre, mal de gorge, aphtes/ulcérations; carnet et conditions de prescription à respecter.

AOD - surveillance biologique

- Avant traitement : Hb, fonction rénale (clairance Cockcroft pour posologie), fonction hépatique.
- Au moins 1 fois/an : Hb, fonction rénale, fonction hépatique.
- Tous les 6 mois : >75 ans, poids <60 kg ou ClCr initiale 30-60 mL/min.
- Tous les 3 mois : ClCr initiale <30 mL/min, si l'AOD concerné est autorisé à ce niveau de fonction rénale.

AVK

- L'INR relève d'un protocole propre avec fréquence adaptée à la stabilité, aux interactions et aux modifications thérapeutiques.
- Ne pas le noyer dans le bilan annuel.